TEMA 13 · Salud comunitaria y grupos vulnerables. Investigación cualitativa y práctica basada en la evidencia

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Salud comunitaria, determinantes sociales, exclusión y participación en la Región de Murcia · Bloque B: Investigación cualitativa (diseños, técnicas, análisis, rigor, CAQDAS) y PBE

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
APS / AP	Atención Primaria de Salud	Puerta de entrada al sistema y base de la salud comunitaria
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, Agenda 2030)	Marco de Astaná
SOC	*Sense of Coherence* (Sentido de Coherencia, Antonovsky)	Base del modelo de activos
DSS	Determinantes Sociales de la Salud	Las "causas de las causas"
SNS / SMS	Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud	
Ley 14/1986 (LGS)	Ley General de Sanidad	Universalidad, Áreas de Salud, AP como nivel básico
Ley 16/2003	Ley de Cohesión y Calidad del SNS	Cartera de servicios comunes
Ley 33/2011	Ley General de Salud Pública	Salud de la población y acción intersectorial
RDL 16/2012 / RDL 7/2018	Reales Decretos-leyes (normas urgentes del Gobierno) sobre el acceso al SNS	El primero limitó la asistencia; el segundo devolvió el acceso universal
Ley 39/2006 / LO 4/2000	Ley de Dependencia / Ley Orgánica de Extranjería	
Ley 4/1994	Ley de Salud de la Región de Murcia	Norma básica del SMS
Ley 3/2021	Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia (sustituye a la Ley 3/2003)	Coordinación sociosanitaria
EpS	Educación para la Salud	Herramienta de la enfermera comunitaria
IAP / IPBC	Investigación-Acción Participativa / Investigación Participativa Basada en la Comunidad	Investigar con la comunidad para transformar
PBE	Práctica Basada en la Evidencia	Evidencia + experiencia + preferencias
CAQDAS	*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software*	Programas de apoyo al análisis cualitativo (ATLAS.ti, NVivo)
CASPe	*Critical Appraisal Skills Programme* España	Plantillas de lectura crítica
JBI / FAME	Instituto Joanna Briggs / *Feasibility, Appropriateness, Meaningfulness, Effectiveness*	Evidencia cualitativa
PICO, SPICE, SPIDER, ECLIPSE	Plantillas para formular la pregunta (tabla de B7)	
GRADE	*Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation*	Calidad de la evidencia cuantitativa

A1. Salud comunitaria: hitos y conceptos

Hito	Aportación
Alma-Ata (1978)	APS como estrategia de **"Salud para Todos"**: equidad, tecnología apropiada, **participación comunitaria** e **intersectorialidad**

Hito	Aportación
Carta de Ottawa (1986)	Marco de la **Promoción de la Salud**: la salud como recurso para la vida, entornos saludables y acción comunitaria
Astaná (2018)	Renueva Alma-Ata para el siglo XXI: **Cobertura Sanitaria Universal**, cronicidad, **tecnología digital**, ODS

- **Salud pública** planifica **para** la población; **salud comunitaria** planifica **con** la población (empoderamiento, corresponsabilidad). Los cuidados de enfermería comunitaria tienen una frecuencia **continua** (SMS 2019).
- **Lillian Wald** (principios del siglo XX, Nueva York): acuñó la expresión **"enfermera de salud pública"** o sanitarista, que trabajaba con inmigrantes pobres.
- **Estrategia de Salud Digital** del Ministerio: atención **"5P"**: **poblacional, preventiva, predictiva, personalizada y participativa**.
- **Gradiente social de salud**: no es "pobres frente a ricos", sino un escalonamiento continuo: a menor posición social, peor salud. "El código postal pesa más que el código genético".
- **Activos para la salud** (modelo **salutogénico de Antonovsky**): cualquier recurso (persona, lugar, asociación) que potencia el bienestar **reconocido como tal por las propias personas implicadas** (**mirada subjetiva**; no lo deciden los profesionales). Un **recurso** es un bien o servicio que puede mejorar la salud (mirada objetiva). Frente al clásico "modelo de déficit".
- **Mapa de activos** (Ministerio de Sanidad): se construye mediante un **proceso participativo** de personas, asociaciones e instituciones (no es un simple inventario). Métodos: **mapeo directo** (un grupo rellena un **mapa vacío** del barrio con los activos), **paseos comunitarios**, **Photovoice** (fotos tomadas por los vecinos) y grupos.
- **Sentido de Coherencia (SOC)**: **comprensibilidad** (entiendo lo que pasa), **manejabilidad** (tengo recursos) y **significatividad** (merece la pena).

A2. Determinantes sociales de la salud (DSS)

- Circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, condicionadas por la distribución del poder, el dinero y los recursos. Las **"causas de las causas"** (OMS).
- **Informe Lalonde (1974)**: 4 campos: **biología humana, estilos de vida, medio ambiente y sistema sanitario** (servicios de salud). "Factores médicos" **no** es uno de ellos. Dever (1976), aplicándolo, ordena su peso en la mortalidad de mayor a menor: **estilos de vida > biología humana > medio ambiente > sistema sanitario**; el sistema sanitario explica en torno al **11%** de la mortalidad, pero recibe alrededor del **90%** del gasto.
- **Dahlgren y Whitehead (1991)**: capas concéntricas: centro (edad, sexo, genética, **no modificables**) → estilos de vida → redes sociales y comunitarias → condiciones de vida y trabajo → condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales generales (la capa externa condiciona a las internas).

Nivel operativo	Ejemplos	Dónde se detecta
Proximales	Tabaco, dieta, ejercicio, adherencia, autocuidado	Consulta
Intermedios	Vivienda (hacinamiento, humedad), empleo precario, educación, transporte, redes sociales	**Visita domiciliaria**
Distales o estructurales	Políticas públicas, Ley de Extranjería, modelo económico, estratificación por clase, género, etnia	Análisis de la comunidad

- **Clase social**: el determinante más consistentemente asociado a desigualdad (menor esperanza de vida, más multimorbilidad precoz).
- **Interseccionalidad**: los riesgos no se suman, **se multiplican** (p. ej., mujer, inmigrante, sin recursos y con cargas familiares).

A3. Marco legal

Norma	Clave
Ley 14/1986, General de Sanidad	Universalidad, Áreas de Salud, AP como nivel básico

Norma	Clave
Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad	**Cartera de Servicios Comunes**: iguala prestaciones en toda España
Ley 33/2011, General de Salud Pública	Salud de las poblaciones, prevención, acción **intersectorial**
RDL 16/2012	Vinculó la condición de asegurado a residencia legal; el **RDL 7/2018** recuperó el acceso universal
Ley 39/2006 y LO 4/2000	Dependencia y Extranjería
Ley 4/1994, de Salud de la Región de Murcia	Norma fundamental del SMS: AP como puerta de entrada, programas comunitarios
Decreto 148/2002	Estructura y órganos del SMS
Ley 3/2003 de Servicios Sociales de la Región de Murcia (hoy sustituida por la Ley 3/2021)	Coordinación sociosanitaria; la enfermera de AP como enlace
Planes de Salud de la Región	"Hoja de ruta" con prioridades (diabetes, obesidad infantil)

A4. Grupos vulnerables y barreras de acceso

- **Exclusión social**: proceso **multidimensional** y continuo (no dicotómico) de privación de recursos, derechos y oportunidades.
- Perfiles en el SMS: pobreza (especialmente **infantil**), personas sin hogar, población **inmigrante** (sector agrícola), población gitana, discapacidad o enfermedad mental grave, mayores en **soledad no deseada** (zonas rurales), población reclusa, víctimas de violencia de género y personas con adicciones.
- **Barreras**: administrativas (tarjeta sanitaria), económicas (copago, transporte), geográficas (diseminados rurales), **lingüísticas** (no usar familiares, y menos a menores, como intérpretes), culturales, organizativas (horarios rígidos) y estigma.
- **Soledad no deseada**: se asocia a **más morbimortalidad**; se mide con la **escala de soledad UCLA**.
- Si un paciente vulnerable no acude a la cita, se sospecha una **barrera**, no falta de interés.

Datos de la Región de Murcia (según el manual)	
Población inmigrante	≈ 15% (Lorca, Torre Pacheco, Mazarrón, Águilas, Campo de Cartagena)
Obesidad en adultos / exceso de peso	20% / > 60%
HTA / DM2	Un tercio / 10%
Obesidad infantil	**> 30%**, ligada al nivel de renta
Primera causa de muerte	Enfermedad cardiovascular
COVID-19 (56.628 casos analizados)	Mayor incidencia en origen africano y latinoamericano; el ámbito laboral pesó más en inmigrantes

- **Paradoja de género**: las mujeres viven más, pero con peor salud percibida, más ansiedad y depresión y más años con discapacidad.

A5. Intervención enfermera y participación comunitaria

- Estrategias eficaces: **multicomponente**, adaptadas culturalmente, participativas y que actúan sobre los DSS. Visita domiciliaria con enfoque social, prevención de obesidad infantil, búsqueda activa del riesgo cardiovascular, prevención de fragilidad y caídas, **agentes comunitarios de salud** (puente con la comunidad; reducen el absentismo) y EpS adaptada a la **alfabetización sanitaria**.
- Líneas de actuación: valoración integral biopsicosocial (registro en **OMI-AP**), detección precoz, **gestión de casos** ("navegadora" del sistema), coordinación intersectorial (el **trabajador social** como socio principal), activos comunitarios, **abogacía por la salud** y evaluación con **enfoque de equidad**.

- **Competencia cultural** y, un paso más allá, **humildad cultural** (reconocer que no se sabe todo de la cultura del otro).

Escalera de Arnstein (1969): 8 peldaños	
No participación	Manipulación, terapia
Participación simbólica	Información, consulta, apaciguamiento
Poder ciudadano (real)	**Asociación**, poder delegado, control ciudadano

- **Niveles de orientación comunitaria en AP**: **nivel 1** individual y familiar ("pasar consulta mirando a la calle"); **nivel 2** grupal (**EpS grupal** sobre "las causas de las causas"); **nivel 3** colectivo (**acción comunitaria**: "el centro de salud no es el único centro de salud"; aquí entra regular por norma los Consejos de Salud y las comisiones de salud comunitaria).
- **Ciclo de la acción comunitaria** (Ministerio, "Acción comunitaria para ganar salud"): **0** punto de partida (conocerse) → **1** hacer equipo y red → **2** explorar la comunidad → **3 analizar y priorizar** → **4** preparar la acción → **5** actuar → **6** evaluar. Sus **pilares**: participación, procesos relacionales y claves de resultado (el análisis de situación es una fase, no un pilar).
- **Redes comunitarias**: estructuras de colaboración para un problema común; su fuerza es la **inclusividad** y la **flexibilidad**; se evalúan **durante todo el proceso**, no solo al final y por su efectividad.
- Una **estrategia de salud comunitaria** debe incluir de forma explícita objetivos, líneas de acción y **presupuesto específico** (no exige "evaluación por un comité de expertos"). Según la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS (2013), su instrumento operativo local es el **plan de salud local** (EIR).
- Órganos: **Consejos de Salud de Zona** (órganos **de participación**; a menudo formales y consultivos), mesas locales de salud. Metodologías: desarrollo comunitario (la enfermera como **facilitadora**, no experta única), **Investigación-Acción Participativa** ("conocer para transformar"; la **Investigación Participativa Basada en la Comunidad** analiza la realidad para mejorarla con un **trabajo conjunto** de investigadores y comunidad), mapeo de activos, grupos focales, **Photovoice**.
- Retos: presión asistencial, falta de tiempo y de formación y resistencia institucional a compartir el poder.

BLOQUE B · Investigación cualitativa y práctica basada en la evidencia

B1. Paradigmas

	Cuantitativo (positivista)	Cualitativo (naturalista o constructivista)
Realidad	Única, objetiva, medible	**Múltiple**, construida socialmente
Investigador	Distante, neutral	Interactivo: **es el principal instrumento**; valores explícitos (**reflexividad**)
Razonamiento	**Deductivo** (general → particular)	**Inductivo** (particular → general)
Objetivo	Explicar, predecir, causalidad	**Comprender** significados y experiencias
Diseño	Rígido, predeterminado	**Flexible, emergente**, circular; las preguntas e hipótesis pueden surgir antes, durante o después de recoger los datos
Resultados	Generalización estadística	**Transferibilidad** y profundidad

B2. Diseños cualitativos

Diseño	Claves
Fenomenología descriptiva (Husserl)	Esencia de la experiencia vivida; **epojé o *bracketing*** (poner entre paréntesis los prejuicios)
Fenomenología hermenéutica (Heidegger)	***Dasein*** (ser-en-el-mundo); la epojé es imposible; **círculo hermenéutico**
Etnografía	Antropología, cultura de un grupo; trabajo de campo prolongado, **observación participante**; perspectiva **emic** (desde dentro, nativa) y **etic** (desde fuera, científica). Escuela de Chicago
Teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967)	Generar teoría desde los datos; **interaccionismo simbólico**, **método comparativo constante** (recogida y análisis **simultáneos**), **muestreo teórico**, categoría central
Investigación-Acción (Kurt Lewin, años 40)	Transformar la realidad; participantes como **coinvestigadores**; espiral: planificar → actuar → observar → reflexionar
Metasíntesis	Síntesis **interpretativa** de estudios cualitativos (no un promedio); **metaetnografía de Noblit y Hare (1988)**
Estudio de caso (Yin, Stake)	Sistema delimitado en profundidad con múltiples fuentes; intrínseco o instrumental
Biográfico-narrativo	Historias de vida (completas) y relatos de vida (un episodio)

B3. Proceso y muestreo

- Fases: **preparatoria** (literatura formal e informal: actas, diarios; contacto con ***gatekeepers*** o porteros, que **facilitan o bloquean el acceso** al campo) → diseño (consentimiento, confidencialidad) → **trabajo de campo** → análisis e informe (con citas literales o ***verbatims***).
- La **revisión de la literatura** solo **orienta** (no tiene el papel fundamental que tiene en la cuantitativa): el problema se plantea **amplio y general**, los datos **emergen poco a poco** y el informe es **flexible**. Muestreo, recogida y análisis van **casi a la vez** (SMS 2019).
- La **fase conceptual** de cualquier investigación incluye la pregunta, el marco teórico y los objetivos; el **análisis de datos no** es de esa fase.
- **Análisis de concepto**: estrategia que revisa la bibliografía para **aclarar el significado** de un fenómeno (p. ej., "fragilidad oral").
- **Muestreo no probabilístico**: **intencional o propositivo** (el de elección general), **bola de nieve** (solo para **poblaciones ocultas** o estigmatizadas), **teórico** (guiado por la teoría emergente), casos extremos y oportunista.
- **Tamaño muestral**: sin fórmulas; se cierra por **saturación de datos** (las nuevas entrevistas no aportan códigos ni categorías nuevas).
- **Reactividad**: cambio de conducta al sentirse observado; se reduce con inmersión prolongada (**rapport**). **Diario de campo**: descripciones y notas reflexivas.

B4. Técnicas de recogida

Roles de observación (Gold, 1958)	
Participante completo	Oculta su identidad: dilemas éticos (engaño) y riesgo de **"volverse nativo"** (*going native*)
Participante observador	Miembro del grupo que revela su rol (p. ej., enfermera que estudia su unidad)
Observador participante	Externo, con participación mínima; prima la observación
Observador completo	Sin interacción (espejos unidireccionales, cámaras)

- **Entrevista en profundidad** (no estructurada, "pregunta detonante") y **semiestructurada** (guion temático flexible).
- **Grupo de discusión o focal**: **6-12 personas**, **homogéneo** (sin asimetrías de poder), **60-120 minutos**, moderador y observador; su fuerza es el **efecto sinérgico** grupal. Matiz del EIR: en el **grupo focal** interesa el **punto de vista de cada persona** (se escucha en grupo, pero se habla como entrevistado individual); en el **grupo de discusión** interesa el **discurso del grupo**.

Técnicas de consenso	Claves
Delphi	Expertos **a distancia y anónimos**, cuestionarios sucesivos (**2-3 rondas**), retroalimentación estadística (mediana, RIC). Evita el **efecto halo**. Inconveniente: lento y con abandonos
Grupo nominal	**Presencial**: generación silenciosa → ronda de exposición (***round-robin***, **sin debate**) → clarificación → **votación** individual
Pecera (*fishbowl*)	Grupos grandes: círculo interior que debate con sillas vacías y círculo exterior que observa

B5. Análisis (Miles y Huberman, 1994)

- Tres flujos **simultáneos e interactivos** (no secuenciales): **reducción** (codificación y categorización), **disposición o visualización** (matrices, mapas, redes) y **extracción y verificación** de conclusiones (volver a los datos para evitar el sesgo confirmatorio).
- **Taylor y Bogdan** (análisis en progreso): **descubrimiento** (leer, buscar temas) → **codificación** (**separar** y agrupar los datos por temas) → **relativización** (interpretar en su contexto).
- **Código**: etiqueta de un fragmento. **Categoría**: agrupa códigos; puede ser **a priori** (deductiva, de la bibliografía) o **emergente** (inductiva, de los datos).

B6. Rigor: criterios de Lincoln y Guba (1985)

Criterio cualitativo	Equivale a	Estrategia principal
Credibilidad	Validez interna	***Member checking*** (devolver la interpretación a los participantes), triangulación, permanencia prolongada, *peer debriefing*
Transferibilidad	Validez externa	**Descripción densa** (*thick description*), muestreo intencional
Dependencia (consistencia)	Fiabilidad	**Pista o auditoría** (*audit trail*) por un auditor externo
Confirmabilidad	Objetividad	**Reflexividad**, trazabilidad de las citas

- **Triangulación (Denzin)**: **de datos** (espacial, temporal y **de personas**: entrevistar a paciente, enfermera y médico sobre un mismo hecho), **de investigadores**, **teórica** y **metodológica** (intramétodo o entremétodos, origen de los métodos mixtos).
- **CASPe cualitativo**: **10 preguntas**; las **2 primeras son de eliminación** (si alguna es "no", se deja de leer), 3-9 de detalle y la 10 sobre aplicabilidad.

B7. Software CAQDAS y práctica basada en la evidencia

- **CAQDAS** (ATLAS.ti, NVivo, MAXQDA): gestionan documentos y multimedia, codifican y recuperan fragmentos, alojan **memos** (forman parte de la pista de auditoría → **dependencia**), crean redes y calculan la concordancia entre codificadores (**kappa de Cohen**). **No analizan ni interpretan**: el análisis es humano.
- **PBE**: integra la **mejor evidencia**, la **experiencia clínica** y las **preferencias del paciente**. Cinco pasos: **pregunta** → **búsqueda** → **lectura crítica** → **implementación** → **evaluación** (la **primera etapa** es **formular la pregunta** sobre una duda de la práctica).

Formato de pregunta	Uso	Siglas
PICO (PIO sin comparación)	Cuantitativa, eficacia	**P**aciente o población, **I**ntervención (p. ej., el programa educativo estructurado), **C**omparación, ***O**utcome* (**resultado**)
SPICE	Cualitativa	***Setting***, *Perspective*, *Intervention*, *Comparison*, *Evaluation*
SPIDER (Cooke)	Cualitativa	***Sample***, *Phenomenon of Interest*, *Design*, *Evaluation*, *Research type*

Formato de pregunta	Uso	Siglas
ECLIPSE	**Gestión** y políticas sanitarias	*Expectation, Client group, Location, Impact, Professionals, SErvice*

- **Instituto Joanna Briggs (JBI, Australia)**: referente en evidencia cualitativa; **criterios FAME**: ***Feasibility*** (factibilidad o viabilidad, incluida la económica), ***Appropriateness*** (adecuación ética y cultural), ***Meaningfulness*** (significado para el paciente) y ***Effectiveness*** (efectividad). **GRADE**, para la evidencia cuantitativa.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Cualitativa = inductiva; cuantitativa = deductiva.**

! Epojé = **Husserl** (descriptiva); *Dasein* = **Heidegger** (hermenéutica).

! *Member checking* asegura la **credibilidad**, no la confirmabilidad.

! Varias personas sobre un mismo hecho = triangulación **de datos (personas)**, no metodológica.

! En SPICE la S es *Setting*; en SPIDER, *Sample*.

Otras preguntas del test de este tema

- **Técnica de las 9 cuestiones** (EpS): es una técnica de **desarrollo de habilidades** (más en el tema 14).